

04 - 05- Trouble Stress Post--Traumatique - Pr. Laffinti

(0:04 - 0:56)

Le stress post-traumatique, en fait, c'est un trouble qui est caractérisé par un ensemble d'éléments cliniques. C'est tout un mélange de symptomatologies cliniques qui sont durables dans le temps, qui sont éventuellement différées, c'est-à-dire pas forcément au décours du traumatisme, et qui s'installe chez une personne qui est exposée à un événement qui est potentiellement traumatisant, où la personne s'est retrouvée face à la mort, ou à la peur de mourir, ou à des blessures graves. Et cette situation a généré chez cette personne un sentiment d'impuissance, un sentiment d'horreur et une peur extrême.

(0:58 - 1:29)

Donc, ça peut être, ça peut concerner la mort de la personne elle-même ou de quelqu'un d'autre. Donc, le sujet commence à, c'est un sujet qui connaît un regain d'intérêt dans tous les médias. Et là, en ce moment, on vient de vivre une tragédie dans la région de l'Eauze, le séisme de l'Eauze, qui est un événement très traumatisant.

(1:29 - 2:09)

Donc, on voit dans les médias, tout le monde parle de soutien, d'accompagnement psychologique pour ces gens qui ont vécu ce drame. C'est un trouble qui était souvent sous diagramme psychique là aussi, parce que les patients ne consultent pas, ne reconnaissent pas le caractère pathologique. Mais avec cette médiatisation, ça risque aussi de tomber, on risque aussi de tomber dans le surdiagnostic et de diagnostiquer de façon abusive.

(2:11 - 2:35)

Dans les classifications récentes, c'est un trouble aussi qui faisait partie des troubles anxieux. Mais actuellement, dans le chapitre actuel, dans les classifications actuelles, que ce soit des SMS et CM11, ça ne fait plus partie des troubles anxieux. Donc, ça constitue désormais un chapitre à part, appelé troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress.

(2:40 - 3:09)

La prévalence, c'est un trouble, comme je disais, qui est assez fréquent avec une prévalence sur une vie qui peut aller jusqu'à 8%. C'est un trouble qui touche deux fois les femmes que les hommes, mais cette prévalence est variable en fonction des populations. Pour des populations qui sont exposées à des événements graves, à des catastrophes naturelles, cette prévalence va bien sûr être beaucoup plus que par rapport à la population générale.

(3:10 - 4:14)

Pour les gens qui viennent de vivre ce séisme dans la région de Lille, on suppose que si on les suit dans le futur, la fréquence du trouble sera beaucoup plus élevée que par rapport aux gens qui n'ont pas été exposés aux mêmes catastrophes. Quand vous voyez les vétérans de la guerre du Vietnam, les soldats américains qui ont participé à la guerre du Vietnam, on fait état d'une prévalence qui va jusqu'à 20% et jusqu'à 40% pour les soldats américains au retour de la guerre du Golfe en Irak. Presque la moitié des soldats ont développé, par la suite, des états de stress post-traumatique parce que la période de guerre, c'est des événements atroces et potentiellement traumatisants.

(4:16 - 5:17)

Dans l'étude clinique du trouble stress post-traumatique, on va aborder l'événement traumatique, les réactions immédiates, le stress aigu, la phase de latence et le trouble stress post-traumatique proprement dit. Pour l'événement traumatique, c'est un événement où la personne va se retrouver confrontée à la réalité de la mort, où il s'est vu vraiment mourir ou a vu quelqu'un mourir ou en tout cas, elle a vécu un événement tellement important, tellement exceptionnellement menaçant de sa vie ou de son intégrité physique. C'est un événement qui va surprendre la personne dans un moment où elle n'est pas préparée, où elle ne s'attend pas à vivre cet événement.

(5:17 - 6:04)

C'est exactement l'exemple qu'on vient de vivre avec le séisme, des gens qui étaient chez eux en train de dormir ou de prendre leur dîner. C'est un moment où personne ne s'y attend pas, qu'une secousse aussi violente s'est produite et a surpris tout le monde avec tous les dégâts qu'on a vécu. C'est un événement bien sûr, cette dimension de surprise, de quelque chose d'incalculable, d'inimaginable, difficile à décrire, qui fait que c'est cette brutalité, cette violence de l'événement qui fait sans son exception.

(6:07 - 7:02)

Ça peut être des catastrophes naturelles comme le séisme, les inondations, l'ouragan de la ville de Darnan, Libye, ça peut être des volcans, des tsunamis, mais ça peut être aussi des catastrophes d'origine humaine, comme l'explosion du port de Beyrouth il y a quelques années, où on a stocké des nitrates d'ammonium avec tous les dégâts que ça a donné. Ça peut aussi être des conflits armés, des moments où des gens vivent des difficultés ou des événements très graves, comme la guerre en Syrie. En tout cas, tous les conflits armés partout dans le monde sont des moments propices d'engendrer ce genre de troubles.

(7:04 - 7:47)

Ça peut être aussi des accidents, des accidents de la voie publique, des accidents de travail, des accidents graves où il y avait une mort violente, ça peut aussi être une personne qui a assisté à

la mort d'une autre personne, une personne heurtée par une voiture sur la voie publique, ou qui a assisté par exemple à un suicide ou à quelqu'un qui est tombé d'une certaine hauteur. Le fait d'y assister est aussi considéré comme un événement traumatisant. Ça pourrait être aussi tout ce qui est agressions, crimes et viols surtout.

(7:47 - 9:26)

Les viols sont aussi des moments très traumatisants, parce que la victime de viol voit son intégrité physique, voire sa vie mise en jeu, donc on ne sait pas si l'agresseur va se contenter de voler ou de violer, mais il peut aussi tuer, donc c'est un moment où la personne peut voir l'intégrité physique ou sa vie menacée. Ça pourrait aussi être un moment bref dans une séquence de sévices ou de torture, surtout chez les personnes en captivité pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, donc avec des tortures régulières, quotidiennes, et ce n'est pas un événement exceptionnel en lui-même, mais des fois ces sévices répétés pendant une longue durée, c'est un moment précis où cette effraction traumatique se fait chez la personne dans ces circonstances. C'est aussi le cas pour des personnes qui ont des visions répétées d'horreur, et là je cite les personnes qui travaillent dans les sauveteurs, les sapeurs-pompiers, qui sont tout le temps amenés à manipuler des cadavres, des fois déchiquetés, et à certains moments ça peut aussi donner lieu à une effraction traumatique.

(9:29 - 10:27)

Donc cet événement traumatisant ou de d'effraction traumatique va être à l'origine d'une réaction, ce qu'on appelle une réaction d'effroi, qui est au-delà de la peur, c'est un moment émotionnel très intense, on va se mélanger le sentiment de peur, le sentiment d'horreur, et surtout le sentiment d'impuissance et d'abandon, lié à cette imminence de la mort. L'événement traumatique va être à l'origine de plusieurs symptômes. Dans l'immédiat, juste après l'événement traumatique ou juste après l'effraction traumatique, on peut trouver des symptômes de toutes sortes, ce qu'on appelle des réactions immédiates-brèves.

(10:27 - 11:03)

Les réactions immédiates-brèves, comme leur nom l'indique, c'est immédiat et c'est bref puisque ça dure moins de 48 heures. Quand les symptômes durent moins de 48 heures, on parle de réactions immédiates-brèves, mais les symptômes peuvent se prolonger et durer plus de deux jours. En tout cas, dans les premières 48 heures, on parle de réactions immédiates-brèves qui sont dominées bien sûr par l'anxiété et l'angoisse face à cette effraction traumatique, face à cet événement traumatisant.

(11:04 - 11:33)

Cette anxiété peut être une anxiété adaptée à la situation qui n'est pas très importante. On parle de stress adapté avec des réactions, par exemple, d'évitement de certains dangers qui peuvent

se voir chez une personne normale. Comme ça peut être des réactions anormalement pathologiques ou exagérées, on parle à ce moment-là de stress dépassé.

(11:34 - 11:50)

Ce stress dépassé peut se manifester par différents troubles. Ça peut être un comportement de sidération avec immobilité, perte de voix, rareté du mouvement. Ça peut aller jusqu'à la stupeur.

(11:51 - 12:30)

Comme ça peut être aussi une certaine agitation, parfois sans but, désordonnée, non fructueuse. Ça peut être une réaction de fuite, panique, qui peut être dangereuse, ce qu'on a aussi vu sur les réseaux sociaux, des gens qui vont courir dans tous les sens sans but, sans objectif, qui peut avoir des conséquences fâcheuses. On a des patients qui se sont jetés au moment du traumatisme de la fenêtre, ils ont eu des dégâts, des fractures des pieds.

(12:31 - 13:03)

Donc c'est cette suite panique qui suit le traumatisme qui peut avoir des conséquences graves. Toujours dans ce stress dépassé, la symptomatologie peut correspondre à ce qu'on appelle la dissociation péritraumatique. C'est très décrit aussi dans le péritraumatisme, juste après le traumatisme, c'est un moment où il y a une altération profonde de la perception, la perception de soi, la perception de l'environnement et même la perception du temps.

(13:03 - 13:52)

Donc avec ces mêmes sentiments de dépersonnalisation et de déréalisation qu'on avait précédemment, donc une personne qui se sent détachée de son propre corps ou qui voit un environnement qui devient hostile, irréel, comme s'il était dans un rêve. C'est aussi une perte de la perception du temps qui va, la personne aura l'impression que le temps s'est arrêté ou se passe au ralenti. Je ne sais pas si vous, dans les films de guerre, ils essaient à chaque fois de schématiser ça après une explosion, un moment on dirait d'arrêt sur image ou de ralenti avant que les choses reprennent leur cours habituels.

(13:53 - 14:24)

Donc la personne a l'impression que la vie s'est arrêtée à un moment où c'est déroulé au ralenti. Des fois, des soldats décrivaient lors de la projection, suite à une explosion, qu'il restait à un moment très long, comme suspendu dans l'air avant de tomber. Donc c'est cette perception du temps qui change dans ce moment de dissociation péri-traumatique.

(14:25 - 14:51)

D'autres réactions peuvent se voir, dont des réactions agressives, des gens dont les suites d'un

traumatisme peuvent avoir un comportement agressif. Un soldat, je pensais, ne leur a apporté que suite à une explosion d'une mine anti-chars. Ils étaient en Afghanistan, en mission en Afghanistan, donc suite à l'explosion d'une mine anti-chars, c'était le véhicule qui était devant lui, donc il y avait des morts.

(14:51 - 15:25)

Dans les suites immédiates, il y avait un Afghan qui était devant sa maison. Elle est partie de façon rapide prendre cette personne et l'a tabassée, l'a agressée devant ses petits, son épouse et ses collègues qui se sont intervenus pour l'empêcher. Donc c'était un comportement agressif incontrôlé et dans les suites immédiates de l'explosion.

(15:27 - 16:19)

Comme ça peut être aussi des accès de confusion ou d'allure maniaque, des gens qui commencent à rire ou avec un certain logoré et qui parlent beaucoup, voire des accès psychotiques de courte durée avec un tableau pseudo-psychotique, ce sont les psychoses réactionnelles que je pense que vous aurez traité dans l'accès psychotique. Donc plusieurs types de symptomatologie peuvent se voir dans les suites immédiates qui suivent un événement traumatisant et donc pour les réactions immédiates. Bref, je disais que ce sont des symptômes qui ne dépassent pas les 48 heures, mais ces symptômes peuvent durer dans le temps et dépasser les 48 heures.

(16:19 - 16:41)

À ce moment-là, on va se retrouver dans ce qu'on appelle le trouble stress aiguë. Le trouble stress aiguë, c'est un trouble qui dure au moins trois jours et ne dépasse pas un mois. Donc c'est un trouble qui doit apparaître dans les quatre semaines suivant l'événement traumatique.

(16:42 - 17:41)

Donc il peut y avoir une période de latence, donc si le traumatisme se produit par exemple aujourd'hui, on peut avoir des réactions brèves qui rentrent dans l'ordre, mais dans la semaine d'après ou les deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard, la personne va commencer à présenter d'autres symptômes. Donc on parle toujours de stress aigu, mais il faut qu'une fois les symptômes vont apparaître, il faut que leur durée ne dépasse pas un mois. Est-ce que vous avez compris ? Donc il faut que les symptômes apparaissent dans le premier mois suivant le traumatisme, soit de façon continue, dès le traumatisme, on a des symptômes qui apparaissent et qui vont continuer, mais qui ne doivent pas dépasser un mois, ou bien des symptômes qui apparaissent dans le premier mois suivant le traumatisme et qui ne dépassent pas un mois toujours.

(17:45 - 18:28)

Donc pour la symptomatologie clinique du trouble stress aigu, ça peut être les mêmes symptômes qu'on vient de voir dans les réactions immédiates, quand ça peut être aussi la même symptomatologie qu'on va traiter dans le trouble stress post-traumatique proprement dit. Donc avant de traiter le trouble stress post-traumatique, il y a la phase de latence que je viens de citer. C'est une phase dont la durée est variable, ça peut aller de quelques heures, quelques semaines ou quelques jours après le traumatisme, quand ça peut se prolonger à plusieurs années ou plusieurs mois.

(18:29 - 20:13)

Donc c'est une phase où la personne va essayer de s'investir sur un investissement professionnel ou des activités associatives ou dans un travail, par exemple, d'artistique, comme la lecture, la peinture, pour essayer bien sûr de contourner cet effet de diffraction traumatique et souvent cette phase peut être indemne de tous symptômes, on ne peut pas trouver de symptômes pendant cette phase de latence, comme à posteriori si on creuse, donc généralement on trouve qu'il y a eu quelques symptômes de l'ordre de trouble de sommeil ou quelques symptômes phobiques ou anxieux ou quelques consommations de substances psychoactives. Donc cette phase de latence va séparer l'événement initial ou le trouble de stress aigu de l'installation du trouble de stress post-traumatique qui va s'installer par la suite. Et puis on arrive au trouble de stress post-traumatique proprement dit, donc le trouble de stress post-traumatique, il peut prolonger le trouble de stress aigu, donc si la symptomatologie du stress aigu dépasse le 1 mois, donc pour le diagnostic de stress aigu, c'est surtout la durée, donc quand la symptomatologie ne dépasse pas le 1 mois, on est devant le stress aigu, mais si la symptomatologie dépasse le 1 mois, on n'est plus dans un stress aigu mais dans un trouble de stress post-traumatique proprement dit.

(20:16 - 21:31)

Donc le déclenchement du trouble de stress post-traumatique, comme je l'ai dit, il peut faire suite directement au trouble de stress aigu sans phase de latence, comme il peut être séparé du trouble de stress aigu par une période de latence qui dure de quelques semaines à plusieurs mois. Et généralement, le trouble se déclenche soit suite à l'exposition à un nouvel événement traumatisant, donc une nouvelle exposition à un événement traumatique, soit suite à quelque chose qui va rappeler de près ou de loin le traumatisme initial, une émission de télé ou un reportage qui parle du traumatisme initial, ou par exemple une situation d'expertise médicale en rapport avec l'événement traumatisant, et le fait de raconter, de rappeler ce traumatisme va peut-être être le point de déclenchement de toute une symptomatologie qu'on va voir. Donc dans le trouble de stress post-traumatique, même après son déclenchement, les personnes ne vont pas consulter rapidement.

(21:31 - 22:33)

Pourquoi? Parce qu'il y a le fait que la personne va croire qu'elle ne va pas être comprise par les autres. Parfois, il y a un sentiment de culpabilité, voire de honte, culpabilité, on parle de culpabilité du survivant, par exemple, un père de famille qui a eu un accident de la voie publique où une personne ou des personnes de sa famille ont perdu leur vie, il va garder cette culpabilité d'être l'auteur de cet accident, donc il ne va pas aller consulter. Pareil pour certains militaires qui expriment ce sentiment de honte de ne pas mourir avec leurs camarades qui ont perdu leur vie lors d'une attaque ou du combat.

(22:37 - 31:16)

La symptomatologie clinique du trouble de stress post-traumatique est très variée, très disparate, mais ce qui est très schématique et très pathognomonique du trouble de stress post-traumatique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de répétition traumatique qui est fait de cauchemars traumatiques et de réviviscences à l'état d'erreur. Les cauchemars traumatiques, ce sont des rêves ou plutôt des cauchemars où la personne va revivre à l'identique, la même scène traumatique, elle va se réveiller dans un état d'angoisse et d'alerte avec les mêmes sensations, les mêmes engagements émotionnels qu'elle a vécu lors du premier traumatisme. Ce sont des rêves très angoissants, très perturbateurs du sommeil de la personne et qui ont un rythme très anarchique, donc ils peuvent être présents toutes les nuits, ils peuvent disparaître plusieurs semaines ou plusieurs mois pour réapparaître sans facteur d'éclosion précis.

Ils vont laisser la personne dans cette angoisse d'attente et de revivre à chaque fois cet événement lors de ses cauchemars. Donc ça donne bien sûr une insomnie, soit une insomnie à cause des cauchemars, mais des fois même la personne va essayer de ne pas dormir pour ne pas revivre la même souffrance du traumatisme. Chaque fois qu'il dort, le cauchemar revient et ça le réveille une nouvelle fois avec la même symptomatologie, la même anxiété, la même angoisse et donc tellement c'est angoissant, c'est gênant que la personne va essayer de ne pas dormir, de ne pas revenir au lit pour ne pas revivre la même angoisse.

Certaines personnes même vont chercher des travaux de nuit, de veille de nuit, de garde de nuit pour justement éviter ces cauchemars. Donc à côté des cauchemars traumatiques, il y a aussi des réveillances à l'état de veille. Donc même à l'état de veille, la personne va avoir des symptômes intrusifs, des images, des pensées ou parfois des perceptions qui permettent de revoir la même scène traumatisante qu'il avait vécue auparavant, avec la même intentionnalité des émotions, les mêmes comportements physiques aussi moteurs qu'il a adoptés lors du premier traumatisme.

Donc tellement il revit la même situation avec toute la charge émotionnelle, toute la charge affective et même les mêmes comportements qu'il a adoptés au préalable. Il faut aussi savoir que ces réveillances sont très sensorialisées, donc ça engage les différents organes de sens. Ça peut être des images, ça peut être aussi des sons, mais ça peut être aussi des odeurs, donc ça peut être aussi des odeurs qui rappellent le traumatisme.

J'avais un patient qui a participé, c'était il y a longtemps, donc quand il y avait le conflit armé avec le franc-polisario, lors d'une attaque, donc il y avait bien sûr des décès, des morts et tout, et c'était à la fin de l'attaque, donc quand il voulait se reposer sous un char, c'est là où il voit des morceaux de la chair humaine brûlée coller au châssis du char, et cette odeur de la chair humaine brûlée, c'est à ce moment-là que ça a fait effraction traumatique dans son esprit, et ces réveillances à lui, c'était une forme d'odeur de la chair humaine brûlée, à tel point que le patient a commencé à utiliser du tabac, à sniffer pour essayer de contourner ces odeurs imprévues qui revenaient à chaque fois. Donc on parle de flashbacks pour ces visions répétées à l'état d'ailleurs. Donc à côté du syndrome de répétition traumatique fait de cauchemars et de réveillances qui est pathogénomique du trouble stress post-traumatique, il y a d'autres symptômes qui se voient chez ces personnes, c'est l'hypervigilance, c'est un état d'alerte permanent, ce sont des personnes qui sont tout le temps sur le qui-vivant, avec des réactions de sursaut au moindre bruit, au moindre claquement de porte, au moindre claquement de voiture.

Donc c'est des personnes qui se sursautent rapidement parce qu'elles sont toujours dans cette ambiance d'attente, d'appréhension, d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre avec la mort. D'autres personnes vont avoir un comportement ou des conduites d'évitement avec un émoussement affectif, avec un retrait social, un repli sur soi, certaines inhibitions, elles vont essayer d'être un peu détachées de leur famille, de la société, s'isoler. On trouve aussi une hyperactivité neurogénétique qui va se traduire surtout par une irritabilité des gens qui s'emportent facilement, qui sont intolérants, qui n'arrivent pas à tolérer la moindre frustration, qui témoignent d'une anxiété et d'une angoisse permanente à chaque fois qu'il y a une situation qui peut rappeler le traumatisme initial.

On trouve aussi des difficultés cognitives, notamment des troubles de concentration, de la tension, de la mémoire chez ces patients. D'autres symptômes peuvent se voir dans le trouble stress post-traumatique constitué. Ce sont des manifestations anxieuses, des attaques de panique, certaines phobies, certains évitements.

Il y a aussi une composante dépressive qui est quasi constante chez des patients souffrant de troubles stress post-traumatiques. Pas forcément un tableau dépressif caractérisé, mais ça peut être aussi une tristesse de l'humeur qui dure, une certaine anhydonie, certaines pertes de plaisir sans remplir les critères d'une véritable dépression. Ce sont aussi des gens qui vont s'adonner à différentes conduites d'échecs, différentes conduites de rupture, donc des ruptures de relations amicales, familiales, des ruptures aussi affectives, des conduites addictives qui sont très fréquentes.

Ce sont des gens qui s'adonnent beaucoup aux substances psychoactives illicites, le cannabis, l'alcool, et aussi des conduites à risque qui sont des équivalents suicidaires, par exemple des conduites d'automobile à de grandes vitesses. Ce sont des conduites qui frôlent aussi les conduites suicidaires. On peut aussi observer un certain remaniement de la personnalité.

À la langue, ce sont des personnes dont les traits de personnalité peuvent, avec le temps, changer. Ils vont adopter une certaine attitude de régression à des stades plus précoces, avec une grande dépendance à leur entourage familial. Ce sont aussi des gens qui vont devenir très revendicateurs, très capricieuses, bien sûr à la recherche de réparation, d'indemnisation et tout.

(31:18 - 31:44)

Vous voyez le trouble stress post-traumatique constitué. C'est un ensemble de symptomatologie qui va regrouper tous les chapitres qu'on a décrits de troubles anxieux, aussi de dépression, de conduites addictives. En dehors du syndrome de répression traumatique qui est pathogénomique, les autres symptômes ne font pas la particularité du trouble stress post-traumatique.

(31:44 - 32:30)

On peut les retrouver dans d'autres troubles, mais le fait de faire une anamnèse, un interrogatoire bien précis, et voir que le changement de caractère et que ces troubles s'installent au décours d'un événement traumatisant, c'est là où on peut faire le lien en rapport avec ce traumatisme. Pour les formes cliniques, juste pour les citer, les formes stress sont des formes généralement où il y a peu de symptômes, souvent très méconnues. Il y a aussi des formes très sévères, très invalidantes, avec des répercussions sur le plan social et en grande dépendance.

(32:31 - 33:19)

En fonction du début, on parle des formes précoces qui vont débiter directement après l'événement traumatique, ou des formes tardives où le trouble stress post-traumatique n'apparaît qu'au-delà de six mois. Et puis, la particularité chez l'enfant et l'adolescent, dont la symptomatologie peut être un peu différente, où on peut trouver chez l'enfant des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage, ou la perte de ce qu'elle a acquis auparavant. Ça peut aussi être un attrait aux jeux dangereux, comme ça peut être aussi des dessins qui sont en lien avec le traumatisme, qui vont rappeler le traumatisme.

(33:19 - 34:11)

Chez les adolescents, c'est surtout des accès de colère, ou parfois des troubles de conduite alimentaire, comme anorexie, boulimie, ou autre. Donc, le diagnostic, il faut bien sûr un repérage actif, donc il faut aller chercher, il faut aller interroger, faire une anamnèse, pour essayer de faire le lien avec le traumatisme, d'autant plus que les personnes ont du mal à aborder ce traumatisme, surtout quand il s'agit aussi de circonstances un peu particulières, comme le cas du viol. Donc, il faut offrir aux patients une ambiance sécurisante, il faut bien sûr établir une relation de confiance et d'empathie pour amener la personne à s'exprimer et aborder le traumatisme.

(34:13 - 34:32)

Donc, quand on a un syndrome de répétition traumatique, bien sûr, le diagnostic est beaucoup plus aisé, parce que ce n'est pas ergonomique. Pour les critères du DSM-5, je ne vais pas mentionner parce que c'est plusieurs critères et c'est un peu difficile. Donc, on passe au diagnostic différentiel.

(34:32 - 34:47)

Pour le diagnostic différentiel, pour le diagnostic avec le trouble stress aiguë, on a vu que c'est une question de temps. Donc, trois jours à un mois, c'est un trouble stress aiguë. La symptomatologie souffre, c'est un trouble stress post-traumatique.

(34:48 - 35:24)

Mais la symptomatologie clinique elle-même ne diffère pas entre les deux entités. Pour le trouble de l'adaptation, c'est un trouble aussi où il y a des manifestations dépressives, des manifestations anxieuses, parfois des troubles de conduite, en rapport avec une situation stressante, sans avoir le caractère d'événement exceptionnel, d'événement dangereux. Mais généralement, c'est une situation de stress où la symptomatologie peut régresser une fois que la personne est extraite de cette situation.

(35:26 - 36:26)

Pour ce qu'on appelle le syndrome subjectif des traumatisés crâniens, ce sont des symptômes que certaines personnes ayant subi un traumatisme crânien peuvent garder pendant plusieurs mois ou plusieurs années des céphalées, des plaintes subjectives de l'ordre des céphalées, de vertiges, de troubles caractériels, et surtout une attitude assez revendicatrice par rapport au traumatisme initial. Mais le traumatisme initial n'a pas cette dimension d'exceptionnel ou de dangereux ou de potentiellement traumatisant. Pour le trouble obsessionnel compulsif qu'on vient de voir, ces idées, ces images intrusives liées au traumatisme a différencié des images obsédantes ou des images obsessionnelles qu'on a traitées plus tard.

(36:26 - 36:51)

Pareil pour les hallucinations, on a une force sensorisation des perceptions lors des révisions à l'état d'éternité. Je vous ai cité l'exemple de l'olfaction. Ce ne sont pas des hallucinations comme dans le trouble psychotique, mais ce sont des perceptions qui rappellent le traumatisme.

(36:56 - 37:36)

L'évolution du trouble stress post-traumatique, c'est les pré-recharges correctement, c'est les diagnostics préalablement. L'évolution est souvent favorable, mais ça peut aussi être une évolution plus chronique et favorable pour des personnes qui ont vécu plusieurs traumatismes,

notamment chez les personnes qui travaillent dans des travaux où il y a toujours cette confrontation au traumatisme. J'ai cité les militaires, les sapeurs-pompiers, les gens de la Sûreté nationale, surtout ceux qui travaillent pour les scientifiques.

(37:39 - 38:32)

Juste en parlant de ces gens-là, pour ouvrir une parenthèse, le DSM-5 a rajouté le fait d'être confronté par rapport au traumatisme initial. Le fait d'entendre ou d'être averti d'un traumatisme d'un proche, de façon brutale, la mort d'un proche, même le fait d'être avisé de la mort d'un proche à une mort violente, la personne peut développer un traumatisme et c'est considéré comme un traumatisme même si la personne n'a pas assisté à la mort, mais elle a été avertie de la mort violente d'un proche. Pareil pour les personnes qui travaillent dans des travaux, qui sont amenées à regarder des scènes d'horreur même derrière leurs écrans.

(38:35 - 38:59)

Mais pas pour les gens qui vont aller chercher eux-mêmes sur les réseaux sociaux des images traumatisantes. C'est spécifique aux gens qui travaillent où le travail l'oblige à regarder des scènes traumatisantes. On arrive à la prise en charge très rapidement.

(39:00 - 39:19)

L'intervention précoce qui suit l'événement traumatisant dans l'immédiat. On parle de soins immédiats appelés défusings. Cette intervention précoce, juste à titre d'indicatif, pas la peine de la prendre par cœur.

(39:19 - 39:47)

Ce défusings concerne les victimes d'un événement exceptionnel comme le cas du séisme. Ça s'adresse aussi à leurs familles, mais aussi aux soldats qui sont sur place. Ça permet d'établir une communication avec ces gens dans ce moment où il y a cet ébranlement de leur affect, de leurs émotions qui sont souvent dans cet état de dissociation apéritraumatique.

(39:48 - 40:16)

C'est une sorte de secourisme psychologique. Ça permet aussi d'atténuer cette anxiété, de soulager la souffrance, mais aussi de détecter les gens qui ont une souffrance importante et qui nécessitent des soins plus appropriés. Toujours dans cette intervention précoce, il y a ce qu'on appelle les soins post-immédiats, appelés débriefings.

(40:16 - 40:29)

Ce débriefing est assuré par des équipes spécialisées formées à cet effet. Sauf que c'est quelque chose de controversé pour certains auteurs. Il faut le faire pour d'autres.

(40:30 - 40:46)

Ils disent que c'est non. C'est quelque chose qu'il faut éviter parce que, pour certains auteurs, ça permet ou ça pourrait favoriser le développement ultérieur du trouble stress post-traumatique. En tout cas, c'est une action qui peut se faire dans les jours qui suivent.

(40:46 - 41:02)

Ça s'adresse aussi aux victimes et aux gens qui ont vécu le même traumatisme. Ça peut se faire de façon individuelle ou collective. Ça permet de reparcourir les émotions et les pensées qui ont été vécues par la personne lors du traumatisme.

(41:06 - 41:32)

Pour le traitement du stress post-traumatique proprement dit, le traitement se fait le plus souvent en ambulatoire. Rarement, on a besoin d'une hospitalisation pour les personnes qui développent des symptômes très sévères ou qui ont des comorbidités associées dépressives ou un risque suicidaire. Le traitement repose aussi bien sur des médicaments que sur d'autres techniques.

(41:32 - 42:00)

Pour les médicaments, ce sont les antidépresseurs qui ont l'AMM pour le trouble stress post-traumatique. Ce sont les inhibiteurs toujours de la recapture de la serotonine qui ont toujours l'AMM, la paroxétine, la sertraline. Ils ont un effet propre sur le trouble stress post-traumatique indépendamment de leur effet antidépresseur.

(42:00 - 42:28)

Ils sont d'autant plus nécessaires et justifiés si une composante anxieuse ou dépressive est associée au trouble stress post-traumatique. La durée, c'est 12 mois au minimum, sinon plus. Pour les autres traitements, le traitement reste des antidépresseurs.

(42:28 - 42:51)

Pour les autres traitements adjuvants, il y a les anxiolytiques. Les benzos sont déconseillés dans la phase aiguë parce qu'apparemment, ils favoriseraient l'apparition du trouble stress post-traumatique. Dans la phase aiguë, on peut se contenter d'hydroxyzine, de tétrazépam ou des bêtas bloquants.

(42:51 - 43:20)

Mais plus tard, dans le test PT constitué, dans des phases de forte angoisse, on peut prescrire de façon ponctuelle, devant une forte anxiété, des molécules benzodiazépines. Pour les antipsychotiques, surtout certaines molécules parmi les classiques, comme la propéridazine, le

nonéléptile. Il est en forme de solution buvable, en forme de goutte.

(43:21 - 43:40)

Il y a aussi la levopiframazine, le nozinol. Ce sont des traitements qui sont utilisés surtout la nuit pour les troubles du sommeil et pour apaiser les cauchemars traumatiques. Il y a aussi les bloqueurs adrénergiques.

(43:40 - 44:00)

Le propranolone, la glucardine, on peut l'utiliser dans l'aiguë et par activité neurovégétative. Un demi à un comprimé par jour. Généralement, c'est une prescription de courte durée et il n'y a pas lieu à la maintenir pendant très longtemps.

(44:01 - 44:29)

Il y a aussi une molécule qui fait parler d'elle, la prazosine, qui n'est pas commercialisée au Maroc. C'est un alpha bloquant qui aurait un effet positif sur les cauchemars traumatiques. Plusieurs écrits disent que cette molécule donne des résultats assez intéressants sur les cauchemars traumatiques.

(44:32 - 45:05)

À côté des traitements pharmacologiques, il y a aussi le traitement psychothérapique. Il y a les techniques de thérapie comportementale et cognitive qui va utiliser certaines techniques d'exposition, soit en imagination ou en réalité virtuelle à l'événement traumatique. Elle va essayer de désensibiliser de façon systématique et progressive cette charge émotionnelle liée au traumatisme.

(45:05 - 45:24)

Ça utilise aussi des techniques de relaxation et d'approche corporelle. Ce sont aussi des techniques qui sont utilisées pour ce genre de patient. Il y a aussi ce qu'on appelle le MDR, High Movement Desensitization and Reprocessing.

(45:26 - 45:56)

C'est une technique de thérapie par les mouvements oculaires. En français, c'est la désensibilisation par les mouvements oculaires et reprogrammation. C'est une technique qui a été découverte de façon fortuite par une psychologue américaine et qui va utiliser le fait de suivre le doigt du thérapeute au moment de l'évocation du traumatisme.

(45:56 - 46:13)

Ça peut être le mouvement oculaire, mais d'autres techniques ont été développées, soit le son de

part et d'autre. Ça stimule l'hémisphère cérébral de façon alternée. Ça peut aussi être un mouvement, ce qu'on appelle le Butterfly Hug.

(46:13 - 46:38)

C'est un mouvement d'ailes de papillons. Le patient va adopter cette position et va taper de façon alternée et de côté. Cette stimulation alternée des hémisphères cérébraux au moment de la thérapie, de l'évocation du traumatisme, permet une certaine dissociation de la charge émotionnelle liée au traumatisme.

(46:39 - 47:03)

Au fil des séances, le traumatisme va perdre de sa charge émotionnelle. Par la suite, ça devient un événement comme un simple souvenir que la personne arrive à inscrire dans sa vie. L'évocation du traumatisme ne va plus être accompagnée de cette anxiété, cette angoisse.

(47:05 - 47:32)

Il y a aussi certaines techniques d'hypnose qui ont été utilisées depuis longtemps et qui sont encore utilisées par certains thérapeutes. La réparation ne fait pas partie du traitement, mais c'est un élément important. Ça aide à la prise en charge de ces patients qui ont vécu un préjudice ou un événement traumatisant, donc un soutien social.

(47:32 - 48:03)

Il y a aussi une réparation pécuniaire, surtout quand il s'agit d'un accident de travail ou, par exemple, pour les militaires, un accident au moment de l'accomplissement de leurs travaux militaires. Cette réparation et cette reconnaissance par l'État, par la société, est aussi quelque chose d'intéressant et qui va aider la prise en charge. Voilà pour le stress post-traumatique.

(48:05 - 48:25)

Comme je l'ai dit, c'est un sujet d'actualité. Bien sûr, le diagnostic demande une anamnèse bien précise pour pouvoir le détecter. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au deuxième chapitre.

(48:33 - 48:58)

C'est bon ? Je vous remercie. Moi, j'ai terminé mes cours. Le reste va être délivré par mes consœurs, mon frère psychiatre François Manaudy, mon professeur Adali, mon professeur Benali et, je pense, mon professeur Bouchara Abassi pour la pédopsychiatrie.

(49:00 - 49:09)

Je vous dis à très bientôt pour les gens qui vont passer dans le service. Au revoir.

